

PREVENTIEF DOEL		BASISPAKKET PREVENTIE	PREVENTIE OP MAAT
LANGER EN BETER LEVEN			
↳ totale mortaliteit betere levenskwaliteit ↳ incidentie verschillende aandoeningen	Rookstop	Navragen en kort advies	Intensievere aanpak
	Bewegen	Navragen en kort advies	Intensievere aanpak
	Voeding (als deel van "ALLES")	Navragen en kort advies	Intensievere aanpak: ALLES + mediterraan
	Alcohol beperken	Navragen en kort advies	Intensievere aanpak
ISCHEMISCHE HART- & VAATZIEKTEN			
↳ mortaliteit en incidentie	Cardiovasculair risicorofiel opstellen (SCORE)	Vanaf 40-45j	Bij jongere patiënten met verhoogd risico owv: -familiaal risico -ernstig psychiatrisch lijden -neuroleptica -reumatische aandoeningen
	Rookstop	Navragen en heel kort advies	Intensievere aanpak
	Bewegen	Navragen en heel kort advies	Intensievere aanpak
	Extra cardiovasculaire preventie		Shared decision making over opstart CV-preventie op basis van: - hoogte CV-risico - effecten en nadelen behandeling - voorkeur patiënt
COPD			
↳ Incidentie, progressie en mortaliteit	Rookstop	Navragen en kort advies	Intensievere aanpak
DIABETES			
↳ Incidentie en progressie	Bewegen Voeding Risico op diabetes inschatten	Navragen en kort advies Verwijs naar ALLES	Intensievere aanpak bij hoger risico (vb. FINDRISC)
		Vanaf 40-45j - samen met CVR-profiel, nuchtere glycemie of FINDRISC)	Op indicatie: FINDRISC vanaf 25j, vb. bij familiaal risico, vragen van patiënt...
LONGKANKER			
↳ Incidentie en mortaliteit ↳ Longkankersterfte	Rookstop	Navragen en kort advies	Intensievere aanpak
	Screening met low dose CT		Geïnformeerde keuze helpen maken - bij (ex-)rokers; > 55j - met > 30 PY - max 10j geleden gestopt - op vraag van patiënt
DIKKEDARMKANKER			
↳ Sterfte door dikkedarmkanker ↳ Incidentie	Screening met iFOBT	Geïnformeerde keuze (GK) helpen maken 50 tot 75j - om de 2 jaar	
	Screening met colonoscopie	<i>Eventueel alternatief voor Ifobt</i> - om de 10 jaar - op vraag patiënt - in theorie niet terugbetaald	Screening/surveillance bij verhoogd risico op dikkedarmkanker
BORSTKANKER			
↳ Borstkankersterfte	Screening met mammografie	Geïnformeerde keuze helpen maken 50 tot 70j - om de 2 jaar	Intensievere screening/surveillance bij verhoogd risico op borstkanker
BAARMOEDERHALSKANKER			
↳ Sterfte door baarmoederhalskanker ↳ Incidentie	Screening met uitstrijkje	Geïnformeerde keuze helpen maken 25 tot 65j - om de 3 jaar	
	Screenen met HPV	<i>Eventueel alternatief voor uitstrijkje</i> - vanaf 30j - om de 5/10 jaar - op vraag patiënt - niet terugbetaald	
SUICIDE			
	Suïcidaliteit bevragen en opvolgen		Bij patiënten die signalen geven van verhoogd risico op suicide
VALINCIDENTEN			
	Valpreventie		Bij patiënten met valincidenten
BROOSHEIDSFRACTUREN			
↳ Incidentie	Fractuurrisico berekenen en SDM over R/ osteoporose	Bij vrouwen tussen 65 - 80j	Bij patiënten met verhoogd risico: - eerdere broosheidsfractuur - meer dan 3m inname systemische corticoïeden - reumatoïde artritis - secundaire osteoporose
	Valpreventie		Bij patiënten met verhoogd risico op broosheidsfracturen:
GRIEP			
↳ Complicaties door griep	Griepvaccin	Vanaf 65j - 1x/jaar	Patiënten met verhoogd risico op complicaties van griep
MAZELEN BOF RUBELLA			
↳ Ernstige complicaties	Basisvaccinatie MBR		Patiënten met onvolledige vaccinatie/geen immuniteit -patiënten geboren tussen 1970 en 1985 -patiënten afkomstig uit landen met precaire gezondheidszorgvoorziening
HEPATITIS B			
↳ Cirrose en hepatocellulair carcinoom	Vaccin tegen hepatitis B		Wanneer geen immuniteit en verhoogd risico op blootselling (vb. nauw contact met actieve drager) - patiënten uit endemische gebieden - patiënten geboren na 1999
TETANUS			
	Tetanusvaccin	Herhaalvaccin - vanaf 25j - om de 10 jaar	Basisvaccinatie bij patiënten die geen basisvaccinatie gehad hebben
INVASIEVE PNEUMOKOKKENZIEKTE			
↳ Ernstige complicaties	Pneumokokkenvaccinatie		Bij patiënten met: -asplenie, sikkcelanemie, immuundepressie -met matig tot ernstig COPD